Bilan biologique — normes françaises

Valeurs usuelles de l'adulte en unités SI, cible INR sous AVK fixée par le prescripteur, pièges d'unités et repères infirmiers, pour réviser en IFSI

Clairance

Référentiel 2009 (entré.e.s en formation avant septembre 2026) : UE en lien, UE 2.1 « Biologie fondamentale » (S1) et UE 4.4 « Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical » (S2, S4, S5)

⚠ PIÈGE Les valeurs usuelles varient selon les laboratoires
Interpréter un résultat avec les valeurs imprimées sur **le compte rendu du laboratoire**. Celles-ci viennent d'un référentiel national publié (adulte), pour réviser.

Valeurs usuelles de l'adulte

Examen	Milieu	Valeurs usuelles	Autre écriture
Ionogramme et calcium			
Sodium (Na^+)	Pl	135–145 mmol/L	
Potassium (K^+)	Pl	3,5–4,5 mmol/L	
Chlorure (Cl^-)	Pl	95–105 mmol/L	
Bicarbonates (HCO_3^-)	Pl	23–27 mmol/L	
Calcium total	Se ou Pl	2,20–2,60 mmol/L	88–104 mg/L
Rein			
Urée	Se ou Pl	2,5–7,5 mmol/L	0,15–0,45 g/L
Créatinine, homme	Se ou Pl	60–115 µmol/L	7–13 mg/L
Créatinine, femme	Se ou Pl	45–105 µmol/L	5–12 mg/L
Clairance de la créatinine (pour 1,73 m²)		1,50–2,30 mL/s	90–140 mL/min
Glucose			
Glucose	Pl	3,90–5,50 mmol/L	0,70–1,00 g/L
HbA1c (part de l'Hb totale)	Sg	< 0,06	< 6 %
NFS (hémogramme)			
Hémoglobine, homme	Sg	130–170 g/L	
Hémoglobine, femme	Sg	120–160 g/L	
Hématocrite, homme	Sg	0,42–0,54	42–54 %
Hématocrite, femme	Sg	0,37–0,47	37–47 %
Hématies, homme	Sg	4,5–5,7 T/L	
Hématies, femme	Sg	4,2–5,2 T/L	
Leucocytes	Sg	4,0–10,0 G/L	
Polynucléaires neutrophiles	Sg	2–7,5 G/L	
Plaquettes	Sg	150–450 G/L	
Hémostase			
Taux de prothrombine (TP)	Pl	70–130 %	
TCA (rapport malade/témoin, sans unité)	Pl	0,80–1,20	
Fibrinogène	Pl	2–4 g/L	
Inflammation			
CRP (protéine C réactive)	Se	< 5 mg/L	
Bilan hépatique et protéines			
ASAT	Se	< 35 UI/L	
ALAT, homme	Se	< 45 UI/L	
ALAT, femme	Se	< 34 UI/L	
GGT, homme	Se	< 55 UI/L	
GGT, femme	Se	< 38 UI/L	
Bilirubine totale	Se ou Pl	< 17 µmol/L	< 10 mg/L
Albumine	Se	38–48 g/L	
Protéines totales	Se	65–80 g/L	
INR sous AVK : cible fixée par le prescripteur			
INR sous AVK, cible la plus courante		2–3	
INR sous AVK, certaines valves mécaniques		3–4,5	

Milieu : Pl plasma, Se sérum, Sg sang. « Autre écriture » : seconde unité donnée par la source (équivalence arrondie). G/L = 10^9/L ; T/L = 10^{12}/L. Valeurs indicatives : elles varient selon le laboratoire.

Fonction rénale : le DFG estimé

Le **DFG estimé** (DFGe) se calcule à partir de la créatininémie (formule CKD-EPI chez l'adulte, recommandée par la HAS) et s'exprime en mL/min/1,73 m². DFGe < 60 pendant plus de 3 mois : maladie rénale chronique de stade 3 ou plus. Au-dessus de 90 : DFG normal ou augmenté (stade 1 si marqueurs d'atteinte rénale).

Pièges d'unités

⚠ PIÈGE Même examen, deux unités
La même glycémie s'écrit 3,90–5,50 mmol/L ou 0,70–1,00 g/L ; la créatinine (homme) 60–115 µmol/L ou 7–13 mg/L. Lire l'unité avant de comparer un résultat à une norme.

⚠ PIÈGE Fraction ou pourcentage
Hématocrite 0,42 = 42 % ; HbA1c < 0,06 = < 6 %. Même valeur, deux écritures (× 100).

⚠ PIÈGE TP, INR, TCA : trois écritures
TP en %, INR sans unité, TCA en **rapport** malade/témoin. Ne pas comparer un TP à une cible d'INR.

✓ EXEMPLE Deux calculs
TCA : 45 s ÷ 30 s = 1,50 (au-dessus de 1,20).
Clairance : 1,50 mL/s × 60 = 90 mL/min.
Valeurs d'exercice (TCA), pas des résultats de patient.e.

Repères infirmiers

✚ NOTE CLINIQUE Kaliémie élevée et hémolyse
Signaler d'abord une kaliémie élevée, selon le protocole du service. Une hémolyse du prélèvement peut donner une fausse hyperkaliémie : un contrôle au laboratoire, sans garrot, peut être demandé. Il ne retarde pas le signalement.

✚ NOTE CLINIQUE INR sous AVK
La cible est fixée par le prescripteur selon l'indication : 2 à 3 le plus souvent, 3 à 4,5 pour certaines valves mécaniques. Au-dessus de la cible : risque de saignement (surdosage possible), à signaler selon le protocole.

Sources : Conseil scientifique des concours de l'internat en pharmacie, « Valeurs biologiques usuelles », V8 (19.11.2009), diffusé par le CNG ; VIDAL Recos « AVK (traitement par) » (21.10.2025) ; VIDAL, estimation du DFG (2022) ; La Revue du Praticien (stades de MRC, 2022 ; hyperkaliémie, 2026).

Rédaction assistée par IA ; contenu vérifié et validé par le vendeur. · Outil de révision. Il complète vos cours et ouvrages de référence, il ne les remplace pas. · Ne remplace ni les protocoles de votre service, ni la prescription médicale, ni l'avis d'un.e professionnel.le de santé.